Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810228

PROCESSO N° 0020685-88.2023.8.17.2001

AUTORA: B. C. P. F.

REPRESENTANTE: ADRIANA REZENDE PINTO CARVALHEIRA PARANHOS FERREIRA

RÉ: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Relatório BEATRIZ CARVALHEIRA PARANHOS FERREIRA, menor impúbere, devidamente representada e qualificando-se pela pena de procurador constituído, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de CAIXA DE ASSIST~ENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, também qualificada, para obrigar a Demandada a custear o tratamento recomendado pelo seu médico assistente.

Reza a inicial que a Autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela Demandada e que foi diagnosticada com baixa estatura idiopática (deficiência de hormônio do crescimento), razão por que seu médico assistente lhe prescreveu tratamento com o uso domiciliar do medicamento denominado "somatropina".

Aduz que solicitou o fornecimento da aludida droga à Parte Ré, sendo que não logrou êxito nessa pretensão.

Com isso, requereu tutela provisória de urgência para compelir a Parte demandada a fornecer o medicamento, pugnando, no mérito, pelo recebimento de indenização por dano moral, pelo ressarcimento das despesas efetuadas no início do tratamento e pela declaração de nulidade de cláusula contratual restritiva.

Juntou documentos.

O pleito antecipatório de tutela de urgência foi denegado (ID de n° 127485709).

No ID de n° 93802193, sobreveio a resposta da Ré em forma de contestação, na qual impugnou, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, arguindo, ainda, inépcia da inicial por formulação de pedido genérico.

No mérito, sustentou, em síntese, que não está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, asseverando que tal sequer está previsto no rol lavrado pela ANS, pelo que defendeu que o pleito excede a cobertura contratual.

Réplica no ID de nº 133398578.

No ID de nº 133795854, aportou decisão do Juízo *Ad Quem* concedendo a tutela provisória de urgência perseguida.

Com vista, o Representante do Ministério Público ofertou parecer favorável ao pleito autoral (ID de nº 135977845).

Autos conclusos. É o que basta relatar.

Gratuidade Judiciária De saída, afasto a impugnação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, eis que a Contestante não logrou êxito em comprovar a inexistência dos requisitos para se deferir a concessão da benesse em favor da Autora.

Ora, é ônus do Impugnante a comprovação da condição econômica do Impugnado, sendo que de tal ônus a Ré não se desincumbiu, porquanto apresentou peça contestatória desprovida de qualquer documento nesse desiderato.

Não é demais reiterar que, para concessão do benefício da justiça gratuita, apura-se a condição financeira da parte postulante, e não de seus representantes legais.

Logo, tratando-se a Autora de pessoa menor impúbere, presume-se que, diante de sua tenra idade, ela não aufere renda com a qual possa custear as despesas processuais.

Razão não há, pois, para que seja negada a benesse.

Preliminar Tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º e 488, do CPC) e, considerando que o resultado da ação é favorável à Demandada, deixo de analisar as preliminares, passando, desde logo, a matéria meritória invocada.

Discussão Cuida-se de pretensões cominatória, indenizatória e declaratória, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre Partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiário de seguro de saúde em face da respectiva Seguradora.

É de saber jurídico que constitui ônus da Parte demandante a comprovação do fato constitutivo de seu direito, sob pena de incidir em sucumbência (art. 373, inc. I, CPC).

No caso dos autos, observo que, muito embora tenha restado demonstrado o quadro clínico da Autora e sua necessidade de se submeter a tratamento com o uso do fármaco indicado na inicial, a Demandante não logrou êxito em comprovar que incumbe à Parte Ré o respectivo custeio.

Ora, desde a decisão inicial, consignei que o pleito autoral esbarra em cláusula contratual validamente pactuada entre as Partes, qual seja, a de número 20, item XX (ID de nº 126931540), a qual não há de ser declarada nula pelo simples fato de ostentar caráter restritivo.

Com efeito, o tão só fato de o pacto albergar restrições e/ou limitações não induz, por si, abusividade, porquanto a prestação de serviço de saúde universal é obrigação do Estado, e não das Operadoras de plano de saúde, sendo lícito, pois, que os contratantes delimitem o sinistro a ser coberto, até porque tal proceder tem repercussão direta no valor das contraprestações.

Deve ser rememorado, ademais, que referida restrição contratual encontra amparo na Lei nº 9.656/1998[1] e na Resolução Normativa nº 465/2021[2], da ANS, as quais preveem a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar apenas para tratamentos antineoplásicos, o que sabidamente não é o caso dos autos.

Nesse diapasão, não socorre a Autora a alegação de que estaria ela enquadrada nas exceções à taxatividade do rol da ANS, já que inexiste alternativa ao tratamento que lhe foi prescrito.

Isso porque a questão posta nos autos não se cinge a estar o não o medicamento previsto no rol da ANS, mas no fato de inexistir obrigação de a Operadora do plano de saúde fornecê-lo, por não se destinar a tratamento antineoplásico.

Ora, a droga perseguida, qual seja, a "somatropina" desserve ao tratamento de câncer, logo, por razões obvias, ela não figura no rol da ANS, inexistindo motivo para se excetuar o rol neste particular, eis que tal significaria violar o disposto na Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 465/2021, já transcritas.

De ver-se, pois, que o pleito da Demandante esbarra frontalmente na legislação de regência e, ainda, em restrição contratual expressa, sendo certo que inexiste razão para afastar a aplicabilidade da cláusula 22, já citada, à míngua de vício capaz de invalidar o negócio jurídico, à inteligência do art. 104, da Lei Civil codificada[3].

Não é demais dizer que a mera indicação médica de utilização do fármaco, por si só, não é suficiente para constituir, em detrimento da Ré, a obrigação de fornecê-los, sendo, necessário, para tal, o mínimo de respaldo legal ou contratual – inexistentes no caso.

É bem verdade que a concessão de todos os medicamentos necessários ao tratamento dos beneficiários de planos de saúde representaria a materialização de uma situação ideal, porém, tratando-se de uma relação jurídica que tem clara disciplina legal, tais normas devem ser respeitadas, mormente porque, como dito, a prestação de serviço de saúde universal é obrigação do Estado[4], o qual, a propósito, dispõe da droga aqui perseguida em suas Farmácias, o que se infere de simples consulta pública ao seu sítio eletrônico[5].

Logo, o fato de não ser a Operadora Ré obrigada a fornecer os medicamentos não retira da Paciente a possibilidade de cura de sua enfermidade, eis que – repise-se - o dever amplo e irrestrito é do Estado, e ele disponibiliza a todos os cidadãos o fornecimento da droga pleiteada.

Ignorar tal fato importaria em desprezar a regulação da atividade de assistência à saúde suplementar promovida pela ANS, que foi criada para esse fim, e obrigar as operadoras a exercer o papel que incumbe ao Estado, o que não pode ser admitido.

Ressalto, por fim, que este Juízo não é insensível à situação da Autora tampouco ignora a proteção de seus direitos, todavia o Poder Judiciário deve atuar com prudência na apreciação de pleitos como o

formulado nestes autos, atentando para o impacto econômico da decisão, sob pena de, a pretexto de garantir a proteção do usuário, ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento das operadoras, o que, em última análise, pode vulnerar os direitos de toda uma coletividade que usufrui da rede privada de assistência à saúde.

A respeito do tema, confira-se o moderno entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

> *DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.*
>
> *1. **"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.***
>
> *Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).*
>
> *2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.*
>
> *3. Agravo interno provido.*
>
> *(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, **julgado em 12/6/2023**, DJe de 19/6/2023).*
>
> *"(...)*
>
> *4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito,*

restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente."

(REsp 1733013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Por fim, quanto aos pleitos ressarcitório e reparatório, devem, consequentemente, ser rejeitados, eis que, uma vez inexistindo dever legal de fornecimento da droga perseguida, não há o que se falar em reembolso de valores tampouco em ilícito praticado pela Ré.

Decisão ISTO POSTO, na esteira de fundamentação supra e do mais visto nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com o que DOU resolução de mérito ao processo, o que faço com suporte no art. 487, inc. I, 2ª parte, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência, CONDENO a Autora no pagamento de verba honorária em favor do(s) patrono(s) da Ré, que arbitro no importe de 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 2°, do Código de Ritos Cíveis, ficando, todavia, sobrestada a exigibilidade por ter aquela litigado sob os auspícios da gratuidade judiciária (cpc, art. 98, § 3°).

Custas dispensadas.

COMUNIQUE-SE o inteiro teor desta decisão à Terceira Câmara Cível do TJPE.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Recife, 10 de julho de 2023.

Dia de Santo Olavo.

Bel. DAMIÃO SEVERIANO DE SOUSA
Juiz de Direito

---

[1] Lei nº 9.656/98
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, ompreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;
Art. 12. Sao facultadas a oferta, a contratacao e a vigencia dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentacoes previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referencia de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigencias minimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
c) cobertura de tratamentos antineoplasicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
II - quando incluir internacao hospitalar:
g) cobertura para tratamentos antineoplasicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterapicos para tratamento de cancer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada a continuidade da assistencia prestada em ambito de internacao hospitalar;

[2] RN nº 465/2021 Art. 20. §1º **São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21, e ressalvado o disposto no art. 14;

[3] Art. 104. *A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.*

[4] Constituição Federal, art. 196. *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

[5] http://www.farmacia.pe.gov.br/medicamento/somatropina (http://www.farmacia.pe.gov.br/medicamento/somatropina) (acesso em 10/07/2023)

Assinado eletronicamente por: **DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA**
10/07/2023 10:54:01
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **137415987**

23071010540146800000134222708

IMPRIMIR GERAR PDF